

TEMA 3.16 • OBSTETRICIA

Embarazo Ectópico — Tratamiento

PERFIL EUNACOM 2.01.2.012

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Embarazo Ectópico — Tratamiento

Resumen del Algoritmo de Manejo

TABLA 3.16.1: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Roto / Hemodinamia inestable	Cirugía urgente (laparotomía o laparoscopia)
Roto / Hemodinamia estable	Laparoscopia (de elección)
No roto, βHCG < 5.000 y sin latidos	Metotrexato (MTX)
No roto, βHCG ≥ 5.000 o latidos (+)	Laparoscopia (MTX contraindicado)
βHCG muy baja (< 200) y bajando	Observación (casos muy seleccionados)

Metotrexato (MTX)

Indicaciones: Ectópico no roto, hemodinamia estable, βHCG < 5.000 UI/L, sin latidos cardíacos fetales.

Contraindicaciones del MTX

TABLA 3.16.2: CONTRAINDICACIÓN VS MOTIVO	
CONTRAINDICACIÓN	MOTIVO
βHCG ≥ 5.000 UI/L	Embarazo grande → riesgo de rotura con MTX
Latidos cardíacos fetales (+)	Embarazo viable → riesgo de rotura
Embarazo heterotópico	MTX mataría también al embrión intrauterino
Masa anexial > 4 cm	Riesgo de rotura (aceptado en varias guías)

Cirugía: Laparoscopia vs. Laparotomía

TABLA 3.16.3: TÉCNICA VS INDICACIÓN	
TÉCNICA	INDICACIÓN
Laparoscopia	Recomendada en estables e inestables cuando disponible y cirujano entrenado
Laparotomía	Alternativa en choque hipovolémico (mayor campo quirúrgico, hemostasia más rápida)

NOTA CLÍNICA

Las guías internacionales recomiendan la laparoscopia incluso en inestables. En Chile se usa más la laparotomía en pacientes choqueadas.

ROGAM

Si madre Rh negativo → **ROGAM** siempre en el manejo del ectópico (metrorragia de primera mitad del embarazo).

Observación

Solo en casos muy seleccionados: βHCG < 200 UI/L y en descenso. Muchos expertos no la recomiendan por el riesgo de rotura.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 28 años con amenorrea de 7 semanas, beta-HCG de 2,500 mUI/mL, dolor en fosa ilíaca derecha y sangrado vaginal escaso. Ecografía TV: cavidad uterina vacía, imagen anexial derecha de 2.5 cm. ¿Conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Embarazo Ectópico — Tratamiento. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Metotrexato (MTX)
- Contraindicaciones del MTX
- Cirugía: Laparoscopia vs. Laparotomía
- Observación
- Roto / Hemodinamia inestable
- Roto / Hemodinamia estable
- No roto, βHCG ≥ 5.000 o latidos (+)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EMBARAZO ECTÓPICO — TRATAMIENTO)

PREGUNTA 1

Mujer de 28 años con amenorrea de 7 semanas, beta-HCG de 2,500 mUI/mL, dolor en fosa ilíaca derecha y sangrado vaginal escaso. Ecografía TV: cavidad uterina vacía, imagen anexial derecha de 2.5 cm. ¿Conducta?

- ☐ A) Legrado uterino por aborto incompleto
- ☐ B) Metotrexato intramuscular — paciente hemodinámicamente estable con criterios
- ☐ C) Esperar evolución espontánea (expectante)
- ☐ D) Laparotomía de urgencia
- ☐ E) Repetir beta-HCG en 48h y si dobla, hospitalizar

PREGUNTA 2

Mujer de 25 años con embarazo ectópico. Llega con PA 70/40 mmHg, FC 130 lpm, abdomen en tabla y dolor generalizado. ¿Conducta inmediata?

- ☐ A) Metotrexato IM y observación 24h
- ☐ B) Beta-HCG urgente para confirmar el diagnóstico
- ☐ C) Laparoscopia/laparotomía de urgencia con reanimación simultánea
- ☐ D) Transfusión de 2 unidades de GR y observar respuesta
- ☐ E) Ecografía TV para confirmar localización antes de operar

PREGUNTA 3

¿Cuál es el factor de riesgo más importante para embarazo ectópico?

- ☐ A) Multiparidad
- ☐ B) Antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) o cirugía tubárica previa
- ☐ C) Uso de anticonceptivos orales combinados
- ☐ D) Nuliparidad
- ☐ E) Síndrome de ovario poliquístico

RESUMEN: EMBARAZO ECTÓPICO — TRATAMIENTO

Indicaciones: Ectópico no roto, hemodinamia estable, β HCG < 5.000 UI/L, sin latidos cardíacos fetales. ::note Las guías internacionales recomiendan la laparoscopia incluso en inestables. En Chile se usa más la laparotomía en pacientes choqueadas. ::: Si madre Rh negativo → ROGAM siempre en el manejo del ectópico (metrorragia de primera mitad del embarazo).